

دليل العلاج المعرفي السلوكي الموجز BCBT



Abdelaziz Aljemaiah

Senior Specialist Clinical Psychology

الوحدة 1: مقدمة عن العلاج السلوكي المعرفي الموجز (bCBT)

الأهداف

• لفهم العلاج المعرفي السلوكي وعملية موجز العلاج المعرفي السلوكي هناك بعض الاعتبارات علينا التقيد بها.

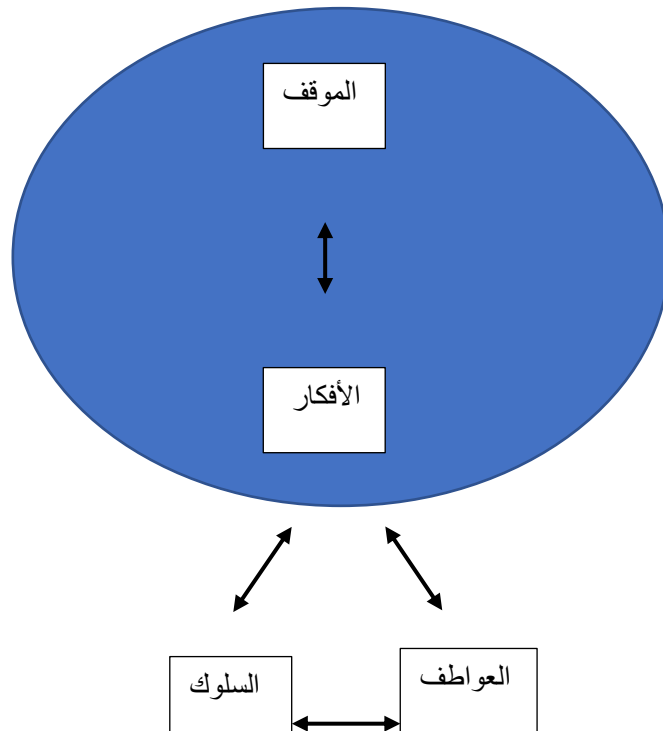
- تحديد اعتبارات العلاج الرئيسية والمشكلات الأكثر ملاءمة للعلاج المعرفي السلوكي الموجز

- لمعرفة كيفية تقييم مدى ملاءمة المريض للعلاج المعرفي السلوكي الموجز

ما هو موجز العلاج المعرفي السلوكي، ولماذا يتطلب اعتبارات علاجية محددة؟

يجمع العلاج المعرفي السلوكي بين العلاجات المعرفية والسلوكية ولديه دعم تجريبي قوي لعلاج المزاج والنوم والألم المزمن واضطرابات القلق (Hoffman & Otto ، 2017 ، Lepping et al. ، 2017 ، Shatkin ، 2018 ، 2018). (الفرضية الأساسية للعلاج المعرفي السلوكي هي أنه من الصعب تغيير العواطف بشكل مباشر، لذلك يستهدف العلاج المعرفي السلوكي العواطف عن طريق تغيير الأفكار والسلوكيات التي تساهم في المشاعر المؤلمة.

الشكل 1.1. النموذج السلوكي المعرفي



يركز هذا الدليل التدريبي على الجيل الثاني من العلاج المعرفي لبيكيان (Beckian Cognitive Therapy) ، والذي

يركز على استخدام تقنيات الاسترخاء وإعادة الهيكلة المعرفية للتأثير على تغيير السلوك. من هذا المنظور، قد نفهم

المشاعر الظرفية على أنها تؤثر على أنماط التفكير والاستجابات السلوكية والحالات العاطفية طويلة الأمد.

يبني العلاج المعرفي السلوكي مجموعة من المهارات التي تمكن الأفراد من القيام بذلك

1. تحديد كيف تؤثر المواقف على الأفكار والسلوكيات

2. كن على دراية بالصلة بين الأفكار والسلوكيات والعواطف

3. تحسين الحالات العاطفية عن طريق تغيير أنماط التفكير غير المفيد والسلوكيات المرتبطة بالأوضاع العاطفية السلبية.

عملية اكتساب مهارات العلاج المعرفي السلوكي هي عملية تعاونية. اكتساب المهارات والواجبات المنزلية هما ما يميز العلاج المعرفي السلوكي عن "العلاجات الكلامية" والعلاجات غير الموجهة. يجب استخدام الوقت المستغرق في الجلسة لمساعدة المريض على اكتساب المهارات اللازمة لمعالجة مشكلة العرض وليس مجرد مناقشة المشكلة مع المريض أو تقديم المشورة. إن تحديد الأفكار والسلوكيات غير المفيدة وتغييرها يميز العلاج المعرفي السلوكي عن علاجات الموجهة الثالثة مثل علاج القبول والالتزام والعلاجات القائمة على اليقظة والعلاج السلوكي الجدلي.

موجز العلاج المعرفي السلوكي هو ضغط مادة العلاج المعرفي السلوكي وتقليل متوسط من 12-20

الجلسات من أربع إلى ثماني جلسات. باختصار العلاج المعرفي السلوكي ينصب التركيز على علاجات محددة لعدد محدود من مشاكل المريض. مطلوب خصوصية العلاج بسبب العدد المحدود من الجلسات. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من المريض أن يكون دؤوبًا في استخدام مواد القراءة الإضافية والواجبات المنزلية للمساعدة في تقدمه العلاجي.

يمكن أن يتراوح العلاج المعرفي السلوكي الموجز في المدة من مريض إلى مريض ومن معالج إلى معالج آخر. سيتم تحديد المدة الدقيقة للعلاج من خلال مجموعة من العوامل التي تشمل مقدم العلاج والمريض وإعدادات اجنדה وهيكلية العلاج. على الرغم من وجود التباين، يعرض الجدول أدناه مثالاً على مخطط تفصيلي لكل جلسة. نشجعك على التفكير بمرونة في تحديد وقت العلاج من جلسة إلى أخرى. كما هو موضح في الجدول، لا يُتوقع منك الالتزام الصارم "بجدول زمني محدد" للتقدم أو الموضوعات ، بل يجب أن تكون مرناً وقابلاً للتكيف في التعامل مع تطبيقات العلاج المعرفي السلوكي الموجزة. قد يوفر العلاج المحدود الوقت حوافز إضافية للمرضى ومقدمي العلاج للعمل بكفاءة وفعالية عالية. على سبيل المثال، غالبًا ما يكون من المفيد العمل ضمن "إطار عمل محدود الجلسات" حيث يتلقى المريض من أربع إلى ست جلسات من العلاج "النشط" ، تليها جلسة متابعة واحدة أو أكثر تحدث على فترات زمنية متزايدة بعد مرحلة العلاج النشط (على سبيل المثال ، أسبوعين بعد العلاج مع جرعة معززة إضافية بعد أربعة أسابيع).

الجدول 1.1 هيكل جلسة موجزة للعلاج المعرفي السلوكي CBT مقترحة

الجلسة	محتوي الجلسة	النماذج الممكنة
الجلسة الأولى	توجيه المريض إلى العلاج المعرفي السلوكي لتقييم مخاوف المريض ضع خطة العلاج الأولية / الأهداف	الوحدة 4: تصور الحالة الوحدة 5: الاعتبارات الثقافية الوحدة 6: استخدام التكنولوجيا الوحدة 7: توجيه المريض الوحدة 8: تحديد الهدف
الجلسة الثانية	تقييم مخاوف المريض (تابع). تعيين الأهداف الأولية (تابع) أو ابدأ تقنيات التدخل العلاجية .	الوحدة 4: تصور الحالة الوحدة 8: تحديد الهدف وحدات التقنية 11-16: الأفكار غير المفيدة ، التنشيط السلوكي ، حل المشكلات ، الاسترخاء ، تقنية التعرض
الجلسة الثالثة	ابدأ / استمر في تقنيات التدخل	وحدات التقنية بان تستخدم التكنيكات العلاجية 16-11
الجلسة الرابعة	مواصلة تقنيات التدخل. إعادة تقييم الأهداف / خطة العلاج	وحدات التقنية 11-16 الوحدة 4: تصور الحالة الوحدة 5: الاعتبارات الثقافية الوحدة 8: تحديد الهدف
الجلسة الخامسة	متابعة تقنيات التدخل.	وحدات التقنية 11-16
الجلسة السادسة	مواصلة تقنيات التدخل.	وحدات التقنية 11-16
الجلسة السابعة	مواصلة تقنيات التدخل.	وحدات التقنية 11-16
الجلسة الثامنة	إنهاء العلاج ومساعدة المريض على الحفاظ على التغييرات.	الوحدة 18: إنهاء العلاج والحفاظ على التغييرات

متى؟ مؤشرات / موانع

بعض المشاكل أكثر ملاءمة للعلاج المعرفي السلوكي القصير من غيرها. يلخص الجدول التالي المشكلات التي قد تساعد في إحاطة العلاج المعرفي السلوكي وقد لا تكون كذلك. تشمل المشاكل التي يمكن أن تُلخص في العلاج المعرفي السلوكي، على سبيل المثال لا الحصر ، اضطرابات التكيف والقلق والاكتئاب. قد يكون العلاج مفيداً أيضاً للمشكلات التي تستهدف أعراضاً معينة (مثل التفكير الاكتئابي) أو تغييرات نمط الحياة (مثل حل المشكلات والاسترخاء) ، سواء كانت هذه المشكلات جزءاً من التشخيص النفسي الرسمي أم لا.

يعتبر العلاج المعرفي السلوكي الموجز مفيداً بشكل خاص في بيئة الرعاية الأولية للمرضى الذين يعانون من القلق والاكتئاب المرتبطين بحالة طبية. نظراً لأن هؤلاء الأفراد غالباً ما يواجهون مشكلات صحية عقلية حادة وليست مزمنة ولديهم العديد من استراتيجيات التأقلم الموجودة بالفعل، يمكن استخدام العلاج المعرفي السلوكي الموجز لتعزيز التكيف. هناك قضايا أخرى تتناول الرعاية الأولية مع العلاج المعرفي السلوكي المختصر ، على سبيل المثال لا الحصر ، النظام الغذائي والتمارين الرياضية والنوم والألم والامتنال للأدوية ومشكلات الصحة العقلية المرتبطة بحالة طبية والتعامل مع مرض مزمن أو تشخيص جديد (Cully et al. ، 2017).

قد لا تكون المشكلات الأخرى مناسبة لاستخدام العلاج المعرفي السلوكي المختصر أو قد تعقد التطبيق المباشر للعلاج المعرفي السلوكي المختصر. لا تعد اضطرابات المحور الثاني ، مثل اضطراب الشخصية الحدية أو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع ، مناسبة عادةً لتجربة علاجية مختصرة ، بسبب المشكلات الاجتماعية والنفسية والعلائقية المنتشرة التي يعاني منها الأفراد المصابون بهذه الاضطرابات. قد لا يكون المرضى الذين يعانون من حالات مرضية أيضاً مناسبين لأن وجود مشكلة ثانية قد يعيق التقدم في العلاج. على سبيل المثال ، قد لا يكون الفرد المصاب بالاعتماد الثانوي على الاكتئاب الشديد مناسباً لأن تعاطي المخدرات يتطلب مستوى أعلى من الرعاية وعلاجاً أكثر شمولاً مما هو متاح في شكل موجز. ومع ذلك ، يمكن استخدام العلاج المعرفي السلوكي الموجز مع المحور الثاني والمخاوف المرضية المشتركة في التعامل مع سلوكيات سلبية معينة أو بالتزامن مع علاج أكثر كثافة.

الجدول 1.2 أمثلة على المشاكل المناسبة وغير المناسبة للعلاج المعرفي السلوكي الموجز

المشكلة	BCBT الموجز	المشكلة	BCBT الموجز
قلق	نعم	إدمان الكحول	ممكن
كآبة	نعم	الشخصية البرنويا	ممكن
توكيد	نعم	اثناء الجائحات	لا
النظام الغذائي (الحمية)	نعم	اضطراب ما بعد الصدمة	نعم
الرياضة (الخمول)	نعم	اضطراب الإجهاد	نعم
العزل الاجتماعي	نعم	الطلاق	نعم
رهاب محدد	ممكن	اضطراب جسدية	نعم
اضطراب الهلع	نعم	اضطراب النوم	ممكن
الحزن / الفجعة	نعم	الم مزمن	نعم
تشخيص جديد لمرض مزمن	نعم	القلق الصحي	نعم
الاكتئاب المصاحب لمرض	نعم	الالتزام بالعلاج	نعم
التصلب اللويحي	نعم	التحفيز (الدافعية)	نعم
القلق الناتج عن امراض القلب	نعم	انفصام فى الشخصية	لا
الذهان الشديد	لا	الإدمان على المخدرات	لا
العلاج الكيميائي	لا	اضطراب الشخصية ثنائي القطب	لا
ضغوط الممارس الصحي	ممكن	الوسواس القهري محدد	نعم

كيف؟ (تعليمات / وتوجيه) للمعالج

اعتبارات مقدم الخدمة العلاجية باستخدام العلاج المعرفي الموجز:

من المهم أن يكون المعالج المعرفي ماهراً ولديه خبرة وتدريب بشكل كافٍ على هذا النوع من العلاج من أجل ان يحدث التعبير في حياة المريض في وقت قصير. يجب عليك انت ك معالج ان تقيم وتطلب الإشراف / المشورة بشكل دوري من

معالج اخر لديه خبرة كبيرة في هذا النوع من العلاج أيضا مناقشته فيما يتعلق بقدراتك في عملية ومحتوى العلاج المعرفي السلوكي الموجز.

فيما يلي مهارات وقدرات المعالج المطلوبة للحصول على العلاج المعرفي السلوكي المختصر:

- القدرة على إقامة علاقة عمل قوية بسرعة مع المريض.
- معرفة وافية بالعلاجات المستخدمة معه .
- القدرة على دمج واستخدام أدلة العلاج.
- تقييم شامل وسريع لمخاوف المرضى.
- المهارة في تنظيم الجلسات ومواد الواجبات المنزلية لمعالجة المشاكل.
- المهارة في تقديم المواد بوضوح ودقة مع أمثلة محددة لكل قضايا ومشكلات المريض.
- المتغيرات الشخصية / الشخصية للمعالج: القدرة على أن تكون حازماً وتوجيهياً وغير تحكمياً وتعاونياً.

تقييم المريض

من الضروري إشراك المرضى المناسبين بشكل تعاوني للعلاج المعرفي السلوكي التقليدي أو أنواع العلاج الأخرى. فيما يلي نقاط مهمة يجب مراعاتها عند اختيار المرضى من أجل العلاج المعرفي السلوكي المختصر. يجب أن يسبق هذا التقييم مرحلة العلاج. قد يعتمد على تقييم التحويل، أو المشكلات من مصدر الإحالة ، أو مراجعة المخطط الطبي.

1 دافع قوى للتغيير

- أ. غالبًا ما يرتبط القلق المتزايد بزيادة الدافع للتغيير.
- ب. ترتبط توقعات العلاج الإيجابية (على سبيل المثال ، معرفة العلاج المعرفي السلوكي والفوائد المتصورة للعلاج) بتحسين النتائج. بدلاً من ذلك ، ليس لدى المريض أفكار ذاتية سلبية قد تعيق التقدم أو التغيير (على سبيل المثال ، "البحث عن الرعاية يعني أنني مجنون" ؛ "لا شيء سأفعله يمكن أن يغير الأشياء").
- ج. المرضى الذين لديهم أهداف واضحة للعلاج هم مرشحون جيّدون.

2 الالتزام بالوقت

- أ. المريض على استعداد لتكريس الوقت اللازم للجلسات الأسبوعية أو نصف الشهرية. ب. استعداد المريض لتكريس طاقته للعمل خارج الجلسة (على سبيل المثال ، الواجب المنزلي).

3 ضغوطات الحياة والدعم الاجتماعي

- أ. قد يؤدي الكثير من ضغوطات الحياة إلى عمل غير مركز و / أو تدخلات متكررة "لإدارة الأزمات".
- ب. من المرجح أن يستفيد المرضى الذين تدعمهم الأسرة والأصدقاء.

4 العمل المعرفي والمستوى التعليمي

- أ. قد تتطلب مهام الواجبات المنزلية المستقلة ومواد القراءة تعديلاً وفقاً للحالة المعرفية للمرضى والمستوى التعليمي.
- ب. المرضى القادرين على العمل بشكل مستقل هم أكثر عرضة للقيام بالعمل بين الجلسات.
- ج. من المرجح أن يستفيد المرضى الذين لديهم تفكير عن العلاج النفسي قصير المدى.

5 شدة المرضى النفسي

- أ. قد يكون علاج المرضى الذين يعانون من أمراض نفسية مرضية أكثر صعوبة في العلاج قصير المدى. بالإضافة إلى ذلك ، تتطلب بعض الحالات مثل تعاطي المخدرات أو الأمراض العقلية الخطيرة تدخلات مركزة وأكثر كثافة.
- ب. المرضى الذين يعانون من تشخيص المحور الثاني هم أقل احتمالاً للاستفادة من العلاج المعرفي السلوكي قصير المدى. غالبًا ما تتطلب المشكلات الشخصية طويلة الأمد فترات علاج أطول.

الوحدة 2: استخدام الإشراف

الأهداف

- مناقشة أهمية الإشراف / التشاور في التدريب على العلاج المعرفي السلوكي
- توفير معلومات حول كيفية استخدام الإشراف والاستشارة السريرية في التدريب على العلاج المعرفي السلوكي
- تحديد نماذج مختلفة للإشراف / التشاور في التدريب على العلاج المعرفي السلوكي
- تقديم نصائح حول اختيار المشرف / الذي سوف يشرف عليك عند تقديم او ممارسة العلاج المعرفي الموجز.

مقدمة

يمكن تقسيم المعرفة حول العلاج النفسي إلى مجالين عريضين ، (1 معرفة المفاهيم و 2) معرفة كيفية تطبيق المفاهيم. ستزودك المعلومات الواردة في هذا الدليل بالمعرفة الأساسية بمفاهيم العلاج المعرفي السلوكي وتحاول تزويدك بنصائح عملية حول كيفية استخدام هذه المفاهيم. ومع ذلك ، نظرًا لأن توفير العلاج المعرفي السلوكي متغير بدرجة كبيرة ، اعتمادًا على المعالج والمريض وإعداد العلاج ، فإن تطبيقات العلاج المعرفي السلوكي تحتاج إلى تخصيصها وممارستها في ظروف العالم الحقيقي. وبالتالي، فإن هذا الدليل هو الخطوة الأولى فقط نحو كفاءة العلاج المعرفي السلوكي. الإشراف والاستشارة طريقتان لتطوير مهارات ممارسة العلاج المعرفي السلوكي من خلال التغذية الراجعة الروتينية والتفاعل مع المعالج المعرفي السلوكي المطلع الذي يمكن أن يعمل كمدرّب / مستشار.

ما هو الإشراف، ولماذا هو مهم في العلاج المعرفي السلوكي؟

تم تصميم الإشراف من أجل أ) تعزيز تطوير المشرف و ب) ضمان رفاهية المريض وسلامته من خلال مراقبة رعاية المرضى. الإشراف ليس علاجًا ؛ على الرغم من أن الإشراف قد يتضمن استكشاف الخبرات الشخصية لمقدم الخدمة ، فإن هذا التركيز يقتصر على المشكلات التي تؤثر على العمل المهني للمعالج (انظر الجدول التالي).

الجدول 2.1 أهداف وتركيز الإشراف

المشرف	- تقديم ملاحظات أداء المعالج - توفير التوجيه واكتساب وجهات النظر البديلة - يساهم في عملية تكوين هوية مقدم الخدمة - بمثابة قاعدة آمنة لاستكشاف التطبيقات والمبادئ العلاجية
المريض	- يضمن حصول المرضى على رعاية مقبولة «- مقدمي لا ضرر ولا ضرار «- يمتلك مقدمو الخدمة مهارات كافية - «يتم علاج أولئك الذين يفتقرون إلى المهارات

الإشراف مقابل الاستشارات

هناك فرق بين الإشراف والاستشارة. في حين أن الإشراف ينطوي على الإشراف المباشر على الحالات السريرية على مدى فترة زمنية (غالبًا ما تتضمن تقييم مقدم العلاج) ، تشير الاستشارة إلى علاقة مصممة للمساعدة في التطوير المهني الذي لا يتضمن إشرافًا رسميًا على الحالات السريرية وقد يستمر أو لا يستمر بمرور الوقت . في جوهرها ، تتضمن التشاور مناقشة موجهة نحو النمو للقضايا أو القضايا دون إشراف أو تقييم.

متى؟ (مؤشرات / موانع)

من الناحية المثالية، يتم الإشراف أو الاستشارة على أساس منتظم. عادة، بالنسبة لمقدمي الخدمات الذين يتعلمون العلاج المعرفي السلوكي ، يجب إجراء الإشراف / التشاور كل أسبوع أو كل أسبوعين. قد تكون الاجتماعات الاستشارية الشهرية مناسبة للممارسين المرخصين في مرحلة أكثر تقدمًا من تدريب العلاج النفسي. قد يؤدي الإشراف و / أو الاستشارة أيضًا إلى زيادة التدريب القائم على ورشة العمل، حيث تقوم ورشة العمل ببناء المهارات الأولية والاستشارة / الإشراف لمساعدة المعالج على تقديم رعاية عالية الجودة أثناء تطبيقات العلاج الرؤية العالم الحقيقي.

كيف؟ (تعليمات / نشرات)

يوضح الجدول التالي الأشكال الأكثر شيوعًا للإشراف. سيتم تحديد فائدة كل إجراء من خلال أهداف الإشراف ومستوى المشرف من التدريب واحتياجات التطوير. يعتبر التعرض لطرائق التدريب المتعددة هو الأكثر فعالية.

الجدول 2.2 الصيغ الشائعة للإشراف

صيغة	وصف	المزايا	السلبيات
تقرير شفهي	يقدم مقدمو العلاج تقريرًا شفهيًا بتفاصيل جلسة أو حالة علاج معينة إلى المشرف.	• أقل تهديدًا لمقدمي الخدمات • يسمح بالتدفق الحر للمناقشة بين المعالج والمشرف	• رهنًا بتذكر مقدم العلاج (أخطاء وسهوا) • محدودة قدرة المشرفين على المراقبة وتقديم التغذية الراجعة حول "عملية" العلاج
ملاحظات العملية	يكتب مقدمو العلاج ويعيدون فرز القضايا التي تم تحديدها في الجلسة جنبًا إلى جنب مع ردود أفعالهم الشخصية والمشاعر التي واجهوها في الجلسة.	• أقل تهديدًا لمقدمي العلاج • تقديم سرد أكثر تفصيلاً للجلسة (مقارنة بالتقرير الشفهي وحده) • البدء في تحديد مشكلات المريض أثناء الجلسة (العملية)	• تخضع لتركيز مقدم الخدمة والتذكر • محدودة القدرة على المراقبة وتقديم التغذية الراجعة بشأن عملية العلاج
تسجيل الصوت / الفيديو	يتم تسجيل الجلسات الفعلية بالصوت أو الفيديو ومراجعتها تحت الإشراف.	• يوفر الوصول إلى محتوى الجلسات الموضوعية والعملية • بمثابة أداة تعليمية ممتازة	• يمكن أن يكون مخيفًا لمقدمي العلاج (وأحيانًا للمرضى) • المسائل اللوجستية - الموافقة المستنيرة المحددة للمرضى ، وتوافر المعدات
إشراف مباشر	المشرف موجود الغرفة تكون (متصلة من خلال تقنية سمعية / بصرية) مع المشرف والمريض أو المشاهدة من خلال نافذة مزدوجة	• تزويد المشرف بدليل في الوقت الفعلي على تنمية المهارات السريرية للمشرف • يسمح للمشرف بتعزيز الأساليب العلاجية و / أو تعلم	• إمكانية فقدان الإشارات غير اللفظية أثناء لقاء الاستشارات إذا كانت متصلة عن طريق الهاتف. • إمكانية تعرض مقدمي العلاج المبتدئين للتهديد أو القلق

	الجوانب. لا يخطر المشرف في العلاج المباشر ، ولكن بدلاً من ذلك يتشاور المشرف مع المشرف في وجود المريض.	الأساليب البديلة في الوقت الحقيقي مع المريض	. احتمال انزعاج المريض من هذا النهج. . إمكانية تقليل مصداقية مقدم الخدمة المبتدئ مع المرضى إذا لم يتم شرح القصد من هذه الطريقة بشكل كافٍ في البداية
الإشراف الجماعي	يتفاعل العديد من المعالجين مع المشرف في شكل مجموعة.	. يوفر التعلم من معالج إلى معالج آخر. . يستخدم جميع التقنيات المذكورة أعلاه بالإضافة إلى تنسيق المجموعة	• التركيز الفردي أقل ، وليس الكثير من الوقت لكل فرد

اختيار مشرف / استشاري

فيما يلي الخصائص التي يجب البحث عنها عند اختيار مشرف أو مستشار CBT

1. المعرفة والخبرة العملية في العلاج المعرفي السلوكي CBT

- من الناحية المثالية، تلقى مشرفو واستشاريون العلاج المعرفي السلوكي تدريباً رسمياً على العلاج المعرفي السلوكي ويستخدمون العلاج المعرفي السلوكي في ممارساتهم السريرية اليومية.

2. التوافر

- بالنسبة لأولئك الذين يتعلمون أولاً كيفية تطبيق العلاج المعرفي السلوكي ، يوصى بشدة أن تحدد المشرفين / الاستشاريين المتاحين للاجتماعات الأسبوعية أو نصف الأسبوعية التي تتضمن في أي مكان من 30 إلى 60 دقيقة لكل اجتماع. يمكن تحديد المدة الفعلية للاجتماعات من خلال عدد الحالات التي يتم استعراضها.
- النظر في القضايا اللوجستية في الجدولة. هل سيكون المشرف / الاستشاري متاحاً للجلسات الشخصية أو الهاتفية (شخصياً أكثر فعالية)؟ ضع في اعتبارك القرب والسفر وتوافر الموارد (على سبيل المثال، تسجيل الصوت / الفيديو).

3. تجربة

مع مجموعة من المرضى مماثلة لتلك التي ستخدمها ، بالإضافة إلى التفكير في تجربة العلاج القصير أو الطويل الأمد.

الوحدة 3: المهارات العلاجية باختصار العلاج المعرفي السلوكي

الأهداف

- لفهم الحاجة إلى علاقة علاجية قوية بشكل أفضل باختصار العلاج المعرفي السلوكي
- لفهم العوامل المرتبطة بعلاقة علاجية قوية
- تعلم استراتيجيات تطوير الوثام وتعظيم العوامل غير المحددة

ما هي المهارات العلاجية، ولماذا هي مهمة في العلاج المعرفي السلوكي؟

العلاج المعرفي السلوكي منظم وموجه نحو الهدف. السياق داعم ، والتقنيات مقترنة بموقف علاجي تعاوني. تشير المهارات العلاجية إلى مكونات علاقة العلاج (على سبيل المثال ، الوثام ، تثبيت الأمل ، الثقة ، التعاون) ويمكن مقارنتها بالمهارات الخاصة بالعلاج التي تشير إلى الجوانب التقنية لتوجيه العلاج النفسي (على سبيل المثال ، التقنيات الفعلية مثل الصور الموجهة ، تحدي الفكر ، إلخ). المهارات العلاجية شائعة في جميع العلاجات النفسية وتعمل كأساس لتحسين المريض. الرجوع إلى تقنيات التدخل الفريدة لنوع العلاج المقدم (على سبيل المثال ، العلاج المعرفي السلوكي ، الديناميكا النفسية ، العلاقات الشخصية). تشير الدراسات إلى أن المهارات العلاجية مسؤولة عن نسبة كبيرة من التغيير المرتبط بالعلاجات النفسية.

متى؟ (مؤشرات / موانع)

المهارات العلاجية حاسمة خلال المراحل المبكرة ومهمة في جميع المراحل من العلاج. تساعد المهارات العلاجية القوية في إشراك المرضى والاحتفاظ بهم في العلاج النفسي وتقوية المكونات التقنية للعلاج. المرضى الذين يرون أن العلاقة العلاجية تعاونية وآمنة وثقة هم في وضع أفضل للاستفادة من العلاج، ومن المرجح أن يكونوا أقل مقاومة وأكثر انفتاحاً على الاستكشاف والتغيير. مع تقدم العلاج، يجب أن تصبح العلاقة العلاجية أقوى، مما يسمح للمعالج والمريض بالانتقال تدريجياً إلى قضايا علاجية أكثر تعقيداً وذات مغزى.

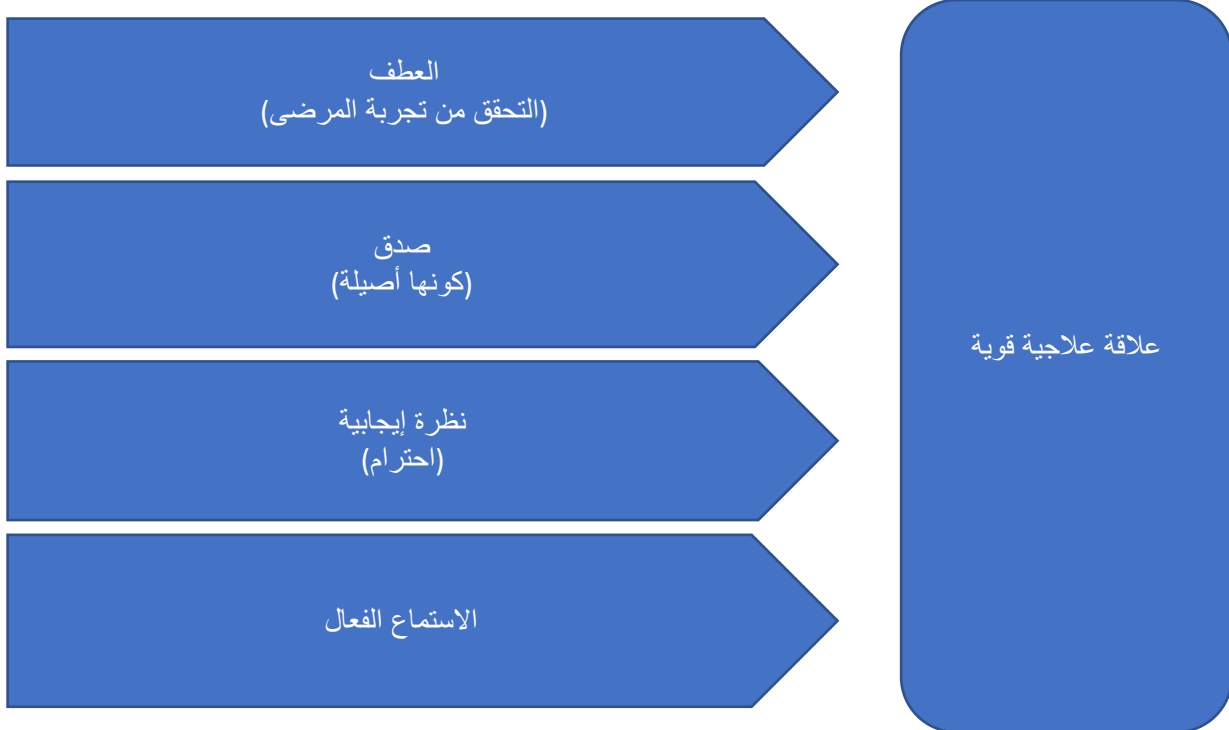
كيف؟ (تعليمات / نشرات)

بالاعتماد على العلاج المتمحور حول الشخص، تركز هذه الوحدة على أربعة عوامل (الشكل 3.1) (مهم لتطوير علاقة علاجية قوية. هذه العوامل هي التعاطف، والصدق، والاحترام الإيجابي. يتم تعريف هذه المفاهيم ومناقشتها وتمثل الخصائص العامة التي يجب على جميع مقدمي العلاج وتحقيقها في العمل مع المرضى. بعد مناقشة هذه المبادئ، يتم تقديم الاستماع النشط كأسلوب للوصول إلى علاقة علاجية قوية بشكل أفضل.

التعاطف (التحقق من تجربة المريض)

التعاطف هو القدرة على فهم التجارب من وجهة نظر شخص آخر. يعتبر التعاطف جزءًا مهمًا من بناء العلاقة ويسهل مشاعر الثقة والاحترام المتبادل بين المريض ومقدم العلاج. من المستحيل أن يكون مقدم العلاج على دراية بالخلفية الفريدة لكل مريض. يعتبر التعاطف، الذي يتألف في الأساس من طرح الأسئلة بطريقة فضولية محترمة والتعبير عن الفهم العاطفي للإجابات المتعلقة ، خطوة أولى قوية نحو فهم الخلفية الحياتية الفريدة للمريض. قد تسهل القراءة الإضافية حول الاختلافات الثقافية أسئلة أكثر استنارة وتحضير مقدم العلاج بشكل أفضل لأسئلة إضافية و / أو تطوير العلاقات. يساعد إظهار التعاطف مع المريض في التحقق من صحة تجاربهم. إن انتقاد ما يشاركه المريض في العلاج غالبًا ما يجعلهم يشعرون بأنهم محكوم عليهم وغير راغبين في الكشف عن معلومات إضافية. استخدم استجابات التحقق لإظهار التعاطف تجاه المريض. التحقق من صحة الردود هو مجرد عبارات عن فهم وجهة نظر المريض. عادةً ما يستلزم التحقق من صحة الاستجابات أن يصف مقدم الخدمة ما سمعه المريض للمريض ، بطريقة غير قضائية.

الشكل 3.1 تطوير علاقة علاجية قوية



الصدق

الأصالة هي القدرة على أن تكون أصيلاً وخالياً من الخداع أو الحكم. يمكنك أن تكون محترفاً وأن تعبر عن هويتك في نفس الوقت. يساعد الصدق في بناء علاقة وتوطيد العلاقة العلاجية من خلال السماح للمريض بالنظر إلى مقدم العلاج كإنسان. غالباً ما يقوم المرضى بتقييم صدق مقدم العلاج للحصول على تعليقات موثوقة حول التقدم المحرز في أدائهم. يتكون الصدق من مجموعة متنوعة من المفاهيم التي تتراوح من السلوكيات غير اللفظية إلى العبارات العلنية. تتضمن أمثلة العوامل المتعلقة بالصدق ما يلي:

دعم السلوك غير اللفظي: يجب أن يكون مقدمو العلاج على دراية بسلوكياتهم غير اللفظية مثل الحفاظ على التواصل البصري ، وإعطاء المريض انتباهك الكامل مثل بديل مثل الحفاظ على الاتصال بالعين ، وإعطاء المريض انتباهك الكامل ، والإيماء بالموافقة أو التفاهم. من المهم أن تتطابق هذه السلوكيات غير اللفظية مع ما يجري في المحادثة، حتى لا تبدو غير طبيعية أو غير حقيقية.

سلوك الدور: يشجع مقدمو العلاج المعرفي السلوكي المرضى على أن يكونوا نشطين وملتزمين ومن ثم يحاولون تسهيل هذا التطور من خلال سلوكهم في العلاج. يمكن لمقدمي العلاج الذين يكونون شديدين في سلطتهم بين الجلسات مع المرضى أن يجعلوا المريض يشعر بالنقص أو التخويف. من المهم أن تتذكر أن العلاقة العلاجية هي علاقة شراكة وأن مقدم العلاج والمريض يعملان معاً للتخفيف من المخاوف والقلق والمشاكل في حياة المريض.

التطابق: يُشار إلى تطابق كلماتك وسلوكك غير اللفظي ومشاعرك مع بعضها البعض على أنها تطابق. قد يؤدي عدم إظهار تطابق مشاعرك وأفكارك إلى إرباك المريض أو تضليله.

العفوية: يتعامل هذا المفهوم مع الطريقة التي يتحدث بها المعالج وتوقيت الردود. تعد الردود والتعليقات المقدمة "في الوقت الحالي" أكثر قيمة من التعليقات المقدمة في وقت لاحق. من المرجح أن يتلقى المرضى رسائل عفوية على أنها أصلية.

نظرة إيجابية

يعني الاحترام الإيجابي ببساطة إظهار الاحترام الذي يستحقونه لجميع المرضى. من الضروري أن نظهر للمرضى أنهم موضع تقدير وأن ما يجب عليهم قوله مهم. غالباً ما يشارك المرضى الذين يشعرون بأن أفكارهم ومشاعرهم معترف بها ومفهومة أكثر ويشعرون بأنهم أكثر ارتباطاً بمقدم العلاج والعملية العلاجية.

قد يكون التواصل الإيجابي أكثر صعوبة مما يبدو ، خاصة إذا كان لديك بعض المعتقدات السلبية عن الشخص الذي تحاول مساعدته. يمكن أن تكون مشاركة أي مشاعر أو معتقدات سلبية حول مرضاك مع مشرفك أو الاستشاري طريقة ممتازة لضمان تطوير وإظهار احترام إيجابي حقيقي لمرضاك.

إن الالتزام تجاه المريض يعني أنك ملتزم بالعمل مع المرضى في أي قضايا يقدمونها في جلسات العلاج. يتضمن ذلك الحضور في الوقت المحدد، وتجنب إلغاء مواعيد المرضى ، وبذل كل الجهود لمساعدة المرضى على التعامل مع هذه المشكلات.

من الضروري أن يكون لديك موقف غير حكمي تجاه أفكار ومشاعر وأفعال المريض. من الممكن قبول وفهم منظور ما دون الموافقة عليه بالضرورة.

يعد إظهار الدفء تجاه المرضى جزءًا حيويًا من بناء العلاقات. يمكن إظهار الدفء من خلال نبذة الصوت وتعبيرات الوجه ومواقف الجسد أو مراعاة ردود أفعالك. يتناول القسم التالي مفهوم الاستماع الفعال. الاستماع الفعال هو أسلوب مفيد لتوصيل العوامل غير المحددة للتعاطف ، والصدق ، والاحترام الإيجابي.

الاستماع الفعال

الاستماع إلى مرضاك هو أساس جميع الأساليب العلاجية. يتكون الاستماع من ثلاث خطوات: استلام رسالة ومعالجتها وإعادة إرسالها. يجب أن يحاول مقدمو العلاج أن يظلوا منفتحين على جميع الرسائل الواردة من مرضاهم (شفهية وغير لفظية) ومحاولة معالجة أكبر عدد ممكن من الرسائل.

توضيح: نظرًا لأننا جميعًا نتحدث من إطار مرجعي خاص بنا ، فقد لا يتم تلقي الرسائل التي نرسلها إلى الآخرين بالطريقة التي نريدها. التوضيح هو أداة مفيدة وضرورية لجميع مقدمي العلاج. يمكن استخدام التوضيح للمساعدة في تبسيط الرسالة التي يتم إرسالها من قبل المرضى أو للمساعدة في تأكيد دقة ما يعتقد مقدمو العلاج أنهم فهموه.

مثال أثناء الجلسة 3.1

المريض	أنا فقط لا أشعر بالرغبة في المحاولة بعد الآن.
المعالج	اخبرني المزيد عما تعنيه
المريض	أنا فقط أشعر بالرغبة في الاستسلام
المعالج	هل تقصد التخلي عن هدفك لإكمال الكلية ؛ أم أنك تشير إلى شيء مختلف ، مثل التخلي عن الحياة وربما إيذاء نفسك؟
المريض	أنا لا أشير إلى الانتحار، إذا كان هذا ما تعنيه ؛ لكنني أشعر بالاكتمال حقًا. يبدو كل يوم وكأنه صراع من هذا القبيل، وغالبًا ما أشعر بالرغبة في البقاء في السرير. عندما قلت "استسلم"، أعتقد أنني كنت أشير إلى عدم الرغبة في مواجهة كل الصعوبات التي أواجهها في الحياة ... عملي المدرسي، والمشاكل المالية ، ومشاكل العلاقة ، إلخ.

لاحظ أن العبارة التوضيحية والسؤال ساعدا مقدم العلاج والمريض على استكشاف مشاعره وأفكاره بشكل كامل. بالنظر إلى هذه المعلومات الجديدة، يكون مقدم العلاج في وضع أفضل لاستكشاف مخاوف المريض وإعداد جهود واستراتيجيات مستهدفة للعلاج.

إعادة الصياغة والتأمل: تتضمن هذه التقنيات إعادة صياغة الأفكار الرئيسية للمريض بطريقة مختلفة أو عكس المشاعر التي يمر بها المريض حاليًا لاكتساب العمق أو التوضيح.

مثال أثناء الجلسة 3.2

المريض	منذ وفاة خطيبي أشعر أن كل يوم هو صراع ؛ وكثيرًا ما أتساءل عما إذا كانت حياتي ستتحسن يومًا ما. أنا فقط أفقده كثيرًا لدرجة أنني أفكر فيه باستمرار. لا أعرف ماذا أفعل ، لكن الألم أصبح أكثر من اللازم.
المعالج	أنت تكافح حقًا من أجل الشعور بالتحسن ، ويأتي الكثير من ألمك من الحزن والفقدان اللذين تشعر بهما من فقدان خطيبك. قد تتساءل حتى عما إذا كان هذا الألم سوف يهدأ أم لا لأنه أصبح لا يمكن السيطرة عليه.
المريض	نعم هذا صحيح. لا أريدك أن تفكر في أنني أفكر فقط في ألم فقده. الألم الذي أشعر به يأتي من شعوري الشديد بالخسارة ، لكن هذا الألم أيضًا لأنني أفقد كل الأشياء التي كان يقصدها لي والفرح الذي جلبه إلى حياتي. أنا أكافح حقًا لأنني لا أريد أن أتركه ، لكن التمسك يؤلمني كثيرًا.

في هذا المثال لإعادة الصياغة، يعيد المعالج للمريض ما سمعه ، مما يسمح للمريض بسماع كلماته والتفاعل مع استجابة أكثر تفصيلاً. سهل استخدام إعادة الصياغة في هذا المثال فهمًا أعمق للمسألة، ولكنه نقل أيضًا إلى المريض شعورًا بأنه يُسمع ويفهم.

الاستماع للموضوعات والبيانات الموجزة: في كثير من الأحيان ، يعبر المرضى عن أفكارهم ومشاعرهم وسلوكياتهم التي تصبح موضوعية عبر المواقف. على الرغم من أن مقدمي العلاج المبتدئين قد يواجهون في البداية صعوبات في تحديد هذا المحتوى الموضوعي ، فإن التكرار بمرور الوقت (على سبيل المثال ، عبر الجلسات) يساعد عادةً في تكوين صورة أوضح للمشكلات العلاجية البارزة التي تتطلب الانتباه أو التركيز. مع الخبرة ، يصبح مقدمو الخدمة أكثر فعالية وكفاءة في تحديد المحتوى الموضوعي.

بمجرد تحديد المحتوى الموضوعي ، يمكن أن يكون آلية قوية جدًا للتأثير على نتائج العلاج. التلخيص هو الأسلوب الذي يضع المحتوى الموضوعي في نطاق اختصاص المريض. التلخيص عبارة عن صياغة مكثفة لاستجابات المريض خلال فترة زمنية محددة (على سبيل المثال ، عبر الجلسة ، منذ بداية العلاج ، منذ بداية الصعوبات الحالية التي يواجهها). يجب عليك إعادة صياغة الموضوعات ، وتكرارها مرة أخرى إلى المريض للتوضيح.

العوائق والتحديات لبناء علاقة علاجية فعالة

يعد وضع الحدود بطريقة متعاطفة أداة أساسية لمقدمي العلاج الجدد. يرغب العديد من مقدمي العلاج الجدد في "تحسين كل شيء"، بحيث يمكنهم تدليل المريض ومواساته وبشتت انتباههم عن العمل على مشكلات أعمق. يمكن للعلاج خلق بيئة عقد من خلال الكلمات المتعاطفة والاستماع الفعال. بيئة الحزم موعد في العيادة هي المكان الذي يشعر فيه المريض أنه يُسمع وأنه في مكان آمن ومضمون للتعبير عن أفكاره ومشاعره دون إصدار حكم.

قد يكون الانتقال من بناء العلاقات الي إقامة علاقة علاجية ممتازة وهذه تحتاج إلى التقييم وتحديد الأهداف ولكنه قد يبدو أمرًا صعبًا. عندما يكون مقدم العلاج والمريض "في نفس الجلسة"، يبدو هذا الانتقال سلسًا. في كثير من الأحيان، ومع ذلك، لا يتحدث المرضى ومقدمو الرعاية بنفس الطريقة واللغة عن مشكلة أو قضية معينة بل قد يختلفوا. على سبيل المثال، قد يشعر مقدم العلاج براحة أكبر عند التعامل مع قضية معينة أولاً. بينما قد يرغب المريض في التركيز على مشكلة مختلفة أولاً. عندما لا يكون المعالج والمريض متطابقين فيما يتعلق بالأهداف، فإن الانتقال بين بناء العلاقة وتحديد الهدف يكون متوترًا. للتغلب على هذه المشكلة، يتم تشجيع مقدمي العلاج على استخدام استراتيجيات المقابلات التحفيزية (انظر Rollnick و Butler و Mason - الفصول 3 و 4 و 5). تتضمن التقنيات الأساسية الاستماع إلى المريض، واتباع رغبة المريض و / أو الدافع، ووضع أهداف تعاونية ومتفق عليها بشكل متبادل. يتضمن أحد الجوانب الحيوية للانتقال من الوثام إلى تحديد الهدف تقييم أهمية وثقة واستعداد المريض بشأن أهداف العلاج المحددة (انظر إعداد الهدف، الوحدة 8).

SUPPLEMENTAL READINGS

Beck, J.S. (2011). *Cognitive therapy: Basics and beyond* (2nd ed.). New York: Guilford Press; Chapter 2.

Cormier, L. S., Nurius, P., & Osborn, C. J. (2017). *Interviewing and change strategies for helpers*. Boston, MA: Cengage Learning; Chapters 3, 4, 5, and 7.

Rollnick, S., Butler, C., & Mason, P. (1999). Chapters 3, 4, and 5. In *Health behavior change: A guide for practitioners*. New York: Churchill Livingstone.

الوحدة 4: تصور الحالة وتخطيط العلاج

الأهداف

- لفهم دور تصور الحالة بشكل أفضل في العلاج المعرفي السلوكي .

- لتطوير مهارات تصور حالة معينة ، بما في ذلك:

أ. تقييم مخاوف المريض / الصعوبات

ب. وضع خطة العلاج (تحديد الهدف) ج. تحديد معوقات العلاج

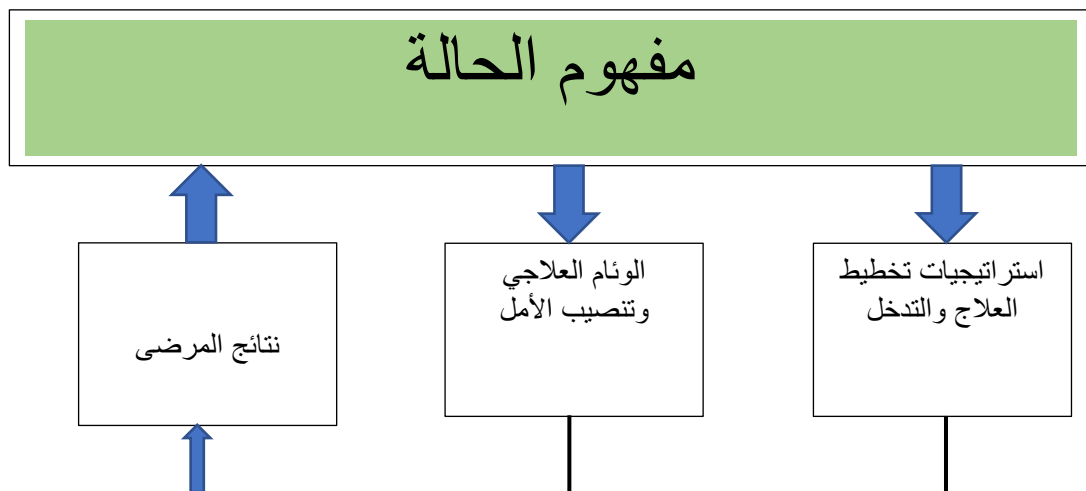
ما المقصود بمفهوم الحالة وتخطيط العلاج ، ولماذا هما مهمان في موجز العلاج المعرفي السلوكي؟

تصور الحالة هو إطار يستخدم لـ (1) فهم المرضى ومشاكلهم الحالية ، (2) تحديد تقنيات العلاج والتدخل و (3) بمثابة أساس لتقييم تغير المريض / تقدمه.

يساعد تصور الحالة أيضًا في إقامة علاقة وإحساس بالأمل للمرضى.

يعتبر تصور الحالة أمرًا حيويًا للعلاج الفعال ويمثل خاصية مميزة لمقدمي العلاج. باستخدام هذه المهارات ، يكون مقدمو العلاج أكثر قدرة على تحديد خطة العلاج باستخدام تقنيات التدخل التي توفر أفضل الفرص للتغيير. يوفر هذا النهج المركز والمستدير خارطة طريق لكل من المرضى ومقدمي العلاج ويجب أن يتضمن أساسًا لتقييم التغيير / التقدم باستخدام مبادئ الرعاية القائمة على القياس. يعتبر تصور الحالة (الشكل 4.1) مهمًا بشكل خاص للعلاج قصير المدى ، حيث إنه يعمل على تركيز كل من المريض والمعالج على القضايا البارزة لتجنب المشكلات الإضافية التي غالبًا ما تكون بمثابة إلهاء للأهداف الأساسية.

الشكل 4.1 تصور الحالة



متى؟ (مؤشرات / موانع)

- يجب أن تبدأ بشكل أفضل خلال الجلسة الأولى وأن يتم تحسينها بشكل متزايد مع تقدم العلاج.
- يجب إجراء تقييم للصعوبات الحالية وإنشاء قائمة بالمشكلات أثناء الجلسة الأولى.
- يجب تحديد خطة العلاج (بما في ذلك أهداف العلاج) في وقت مبكر من العلاج (الجلسات 1 ، 2). قد يتطلب التصور المبكر وتخطيط العلاج تعديلاً عندما تتوفر معلومات إضافية.
- يجب إعادة النظر في خطط العلاج وأهدافه بشكل روتيني للتأكد من أن المريض يتحسن ويتفق مع تدفق العمل العلاجي.

كيف؟ (تعليمات / نشرات)

1. مفهوم الحالة الخطوة 1: تقييم مخاوف المريض / الصعوبات يمكن تقييم مخاوف المريض الحالية وأدائه الحالي بعدة طرق مختلفة. يوضح القسم التالي العديد من السبل الممكنة لتحديد المشاكل / المخاوف.
- (أ) استخدام قوائم جرد أعراض التقرير الذاتي.** تتضمن الممارسة الشائعة في العلاج المعرفي السلوكي استخدام مقاييس أعراض التقرير الذاتي لتقييم أداء خط الأساس بالإضافة إلى التقدم العلاجي. تشمل المقاييس المستخدمة بشكل متكرر للاكتئاب والقلق قائمة - Beck Depression Inventory الإصدار الثاني ، واستبيان صحة المريض -9 (الاكتئاب) ، ومقياس الاكتئاب عند كبار السن ، وجرّد Beck للقلق ، واضطراب القلق المعمم على مقياس مكون من 7 عناصر.
- غالبًا ما يتم إكمال إجراءات التقرير الذاتي من قبل المرضى أثناء تواجدهم في غرفة الانتظار ويتم تقييمها من قبل المعالج أثناء الجلسة. غالبًا ما تكون تدابير التقرير الذاتي بمثابة بند روتيني في جدول الأعمال أثناء جلسات العلاج المعرفي السلوكي وتسلط الضوء على التحسينات المهمة و / أو الأعراض المستمرة. يمكن أن توفر المعلومات التي تم الحصول عليها من قوائم جرد التقرير الذاتي هذه أيضًا نظرة ثاقبة للطريقة التي يفكر بها المريض ويتصرف بها والعوامل التي قد تكون مجالات مهمة للحاجة وستُعلم تقدم العلاج واستمرار / توقف العلاج.
- (ب) قوائم المشاكل.** هذه استراتيجية شائعة ومفيدة لتحديد الصعوبات النفسية والاجتماعية والمهنية والمالية التي يواجهها المرضى. عادةً ما يستخرج مقدمو الخدمات الذين يستخدمون قوائم المشكلات قائمة من خمسة إلى 10 صعوبات من المريض خلال الجزء الأول من الجلسة 1. يتم تحديد المشكلات بشكل أفضل باستخدام أسئلة مفتوحة (على سبيل المثال ، "ما الذي يقودك إلى هذه العيادة؟" "تحب التركيز عليها في عملنا معًا؟"). يتم وصف المشكلات بشكل أفضل من حيث تكرار الأعراض (كم مرة تحدث الأعراض؟) ، والشدة (ما مدى خفيفة أو شدة ذلك؟) والتأثير الوظيفي (ما هو تأثير الأعراض على الأداء اليومي أو الضائقة العامة؟).

قد يصف بعض المرضى صعوباتهم أو أهدافهم بطرق غامضة أو مجردة ، مثل ، "أريد تحسين حياتي" أو أريد أن أكون سعيدًا مرة أخرى. " من الأفضل وصف المشكلات والأهداف اللاحقة بعبارات محددة للحفاظ على التركيز السريري. على سبيل المثال ، يتم سرد مشاكل محددة في الجدول التالي.

مثال على قائمة المشكلات الجدول 4.1

مشكلة	تكرر	خطورة	تأثير
العزل الاجتماعي	ابق في المنزل من ستة إلى سبعة أيام	اتصالات اجتماعية محدودة؛ عزلة متوسطة إلى شديدة	محزن للغاية منهك اجتماعيا. الأسرة / الأصدقاء المبعدة
الم	اختبر الألم كل ساعة	شدة الألم عالية من 7 ، إلى 10 ، عند وجودها	يؤدي الألم إلى انخفاض مستوى النشاط وعدم القدرة على العمل
مشاعر انعدام القيمة	تحدث من ثلاثة إلى سبعة أيام	شديد جدا عند وجوده ؛ في بعض الأحيان تنطوي على أفكار انتحارية	محزن للغاية التأثير على العمل والعلاقات الاجتماعية والحميمة
إعياء أو خمول	يحدث بشكل مستمر تقريبًا	ليست شديدة ولكنها مزعجة	انخفاض مستوى النشاط ، وتكرار القبول ، وعدم القدرة على إكمال المهام اليومية

(ج) تقييم الإدراك. ضمن نموذج العلاج المعرفي السلوكي، غالبًا ما يكون من المفيد فحص أفكار المريض، لا سيما كيف يدرکها المريض. من الطرق المنظمة والمستخدمه بشكل شائع لفحص هذه العوامل تقييم (طرح الأسئلة المتعلقة بالأفكار السلبية) كيف يرى المرضى أنفسهم. على سبيل المثال، قد يصف المريض نفسه بأنه غير قادر أو غير مفيد أو عبء على الآخرين. قد يرون عمومًا أن الآخرين ينتقدون أو يصعب إرضائهم. وقد تكون وجهة نظرهم عن المستقبل متشائمة إلى حد كبير وتنطوي على اعتقاد بأن المستقبل سيتضمن فقط المزيد من الخسائر وخيبات الأمل (انظر أيضًا سجلات الأفكار في الوجدتين 11 و 12).

(د) تقييم السلوكيات وتعجيل المواقف. المواقف المتعجلة هي الأحداث، أو السلوكيات أو الأفكار أو العواطف التي تنشط أو تحفز أو تزيد من صعوبات المريض.

نموذج السوابق والسلوك والنتائج (ABC) هو نموذج لفحص السلوك (الأعراض) في سياق أكبر. إنه يفترض أن السلوكيات يتم تحديدها إلى حد كبير من خلال السوابق (الأحداث التي تسبق السلوك / الأفكار / الحالة المزاجية) والعواقب (الأحداث التي تتبع السلوك / الأفكار / الحالة المزاجية).

يستخدم نموذج ABC (انظر ورقة العمل في نهاية هذه الوحدة) في التقييم الوظيفي. يتبع فرضية أن السلوك (ب) يتشكل من خلال السوابق (أ) والعواقب (ج). تحدث السابقة قبل السلوك وقد تكون محفزًا لرد فعل معين لدى المريض. السلوك هو

أي نشاط (حتى فكرة أو شعور) يظهره المريض استجابةً لسابقة. العواقب هي الأحداث التي تحدث بعد السلوك وتوجه المريض إما لمواصلة أو وقف السلوك.

كما أنها تخضع أيضًا لعوامل سياقية (ظرفية) وعلائقية (شخصية). على سبيل المثال، قد يشعر المرضى الذين يبلغون عن مزاج مكتئب (عاطفة) بالسوء عندما يكونون بمفردهم في المنزل في وقت متأخر من الليل (سابقة في السياق) أو أفضل عندما يكونون مع العائلة (سابقة علائقية). بدلاً من ذلك، قد يشعرون بالاكتئاب من خلال التفكير ، "سأظل وحيدًا دائمًا" (سابقة معرفية). من المهم أن نتذكر أن السوابق يمكن أن تزيد وتقلل سلوك معين.

لمساعدة المرضى في التعرف على السوابق، علمهم تحديد الظروف التي تؤثر على سلوكهم.

مثال أثناء الجلسة 4.1

"ما الذي كنت تشعر به قبل أن تفعل ذلك؟" (عاطفي)

"ماذا يحدث لك جسديًا قبل أن يحدث هذا؟ هل تشعر بالمرض؟" (جسديًا) "كيف تتصرف عادة بشكل صحيح قبل

حدوث ذلك؟" (سلوكي)

"ما الأفكار التي تدور في ذهنك قبل حدوث ذلك؟" (معرفي)

"أين ومتى يحدث هذا عادة؟" (سياقي)

"هل تفعل هذا مع الجميع، أم فقط عندما تكون حول أشخاص معينين؟" (علائقية)

(ب) السلوكيات: السلوك هو أي شيء يفعله المريض أو يشعر به أو يفكر فيه بعد التحدث مباشرة عن مشكلته. يمكن أن يتضمن كل سلوك يعرضه المريض عنصرًا عاطفيًا (المشاعر أو الحالة المزاجية)، ومكونًا جسديًا (أحاسيس جسدية مثل سرعة ضربات القلب أو آلام المعدة) ، ومكونًا سلوكيًا (ما يفعله المريض أو لا يفعله) ، ومكونًا إدراكيًا المكون (الأفكار أو المعتقدات).

(ج) النتائج: يتم تصنيف النتائج على أنها إما إيجابية أو سلبية. تزيد النتائج الإيجابية من فرص تكرار السلوك من خلال تجربة شيء ممتع أو إزالة شيء سلبي (على سبيل المثال، ليس عليك القيام بعمل روتيني). تقلل العواقب السلبية من حدوث السلوك، إما عن طريق وجود شيء ضار (على سبيل المثال ، الصراخ في وجهه) أو عدم وجود شيء مرغوب فيه (على سبيل المثال ، الطفل الذي يتم إبعاده عن مشاهدة التلفزيون). يميل المرضى إلى تكرار السلوكيات التي تؤدي إلى شيء إيجابي أو إزالة شيء سلبي.

تحديد العواقب. على غرار تحديد السوابق، عندما تحاول أنت ومريض تحديد عواقب سلوك معين ، من المهم استكشاف جميع مكونات كل نتيجة.

مثال أثناء الجلسة 4.2

"ما هو شعورك فور حدوث ذلك؟" (عاطفي)

"هل لديك أي أحاسيس جسدية بعد حدوث هذا ، مثل الارتعاش؟" (جسدياً) "كيف تتصرف بعد حدوث هذا السلوك؟"

(سلوكي)

"ما رأيك بعد حدوث ذلك؟" (معرفي)

"هل أنت في مكان مختلف عندما ينتهي هذا السلوك؟" (سياقي)

"هل هناك من يجعل هذا السلوك أسوأ؟ إجعله أفضل؟" (علائقية)

(ب) السلوكيات: السلوك هو أي شيء يفعله المريض أو يشعر به أو يفكر فيه بعد التحدث مباشرة عن مشكلته. يمكن أن يتضمن كل سلوك يعرضه المريض عنصراً عاطفياً (المشاعر أو الحالة المزاجية) ، ومكوناً جسدياً (أحاسيس جسدية مثل سرعة ضربات القلب أو آلام المعدة) ، ومكوناً سلوكياً (ما يفعله المريض أو لا يفعله) ، ومكوناً إدراكياً المكون (الأفكار أو المعتقدات).

(ج) النتائج: يتم تصنيف النتائج على أنها إما إيجابية أو سلبية. تزيد النتائج الإيجابية من فرص تكرار السلوك من خلال تجربة شيء ممتع أو إزالة شيء سلبي (على سبيل المثال، ليس عليك القيام بعمل روتيني). تقلل العواقب السلبية من حدوث السلوك، إما عن طريق وجود شيء ضار (على سبيل المثال ، الصراخ في وجهه) أو عدم وجود شيء مرغوب فيه (على سبيل المثال ، الطفل الذي يتم إبعاده عن مشاهدة التلفزيون). يميل المرضى إلى تكرار السلوكيات التي تؤدي إلى شيء إيجابي أو إزالة شيء سلبي.

تحديد العواقب. على غرار تحديد السوابق، عندما تحاول أنت ومريض تحديد عواقب سلوك معين ، من المهم استكشاف جميع مكونات كل نتيجة.

مثال أثناء الجلسة 4.2

"ما هو شعورك فور حدوث ذلك؟" (عاطفي)
"هل لديك أي أحاسيس جسدية بعد حدوث هذا ، مثل الارتعاش؟" (جسديًا) "كيف تتصرف بعد حدوث هذا السلوك؟"
(سلوكي)
"ما رأيك بعد حدوث ذلك؟" (معرفي)
"هل أنت في مكان مختلف عندما ينتهي هذا السلوك؟" (سياقي)
"هل هناك من يجعل هذا السلوك أسوأ؟ إجعله أفضل؟" (علائقية)

عند الانتهاء من تقييم وظيفي، قم بفحص العواقب قصيرة وطويلة المدى. تميل العواقب قصيرة المدى إلى أن تكون معززات سلوكية، بينما تميل العواقب طويلة المدى إلى أن تكون نتائج سلبية. في حالة الإدمان، فإن النتيجة قصيرة المدى لاستخدام مادة ما هي التسمم أو الهروب من الحالة المزاجية السلبية ؛ قد تكون العاقبة طويلة الأمد مشكلة قانونية أو مشاكل عائلية أو مخالفات. يساعد فهم النتائج الإيجابية والسلبية للسلوك على المريض في تصميم توقيت وطبيعة التدخل. على سبيل المثال، في الحالة المذكورة أعلاه ، سيحتاج التدخل إلى اتباع سابقة ضارة لتعويض الحالة المزاجية السلبية التي يسببها. ومن ثم فإن معالجة الحالة المزاجية السلبية تقلل من الحاجة للهروب من خلال تعاطي المخدرات. يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الأسئلة لتوضيح نتيجة قصيرة المدى:

مثال أثناء الجلسة 4.3

"هل يلتفت هذا السلوك انتباهك بطريقة ما؟"
"ما الأشياء الجيدة التي تحدث نتيجة لهذا السلوك؟"
"هل يساعدك هذا بطريقة ما؟"
"هل تشعر ببعض الاندفاع "لفعل هذا؟"
"هل يساعدك هذا السلوك في تجنب شيء لا تريد القيام به؟"

2. مفهوم الحالة الخطوة 2: الفرضيات السريرية وخطة العلاج

إن وضع فرضيات إكلينيكية مركزة بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها في خطوة تصور الحالة رقم 1 يعمل على توجيه خيارات التدخل وتقنيات العلاج الممكنة. قد تتطلب هذه الفرضيات التكيف مع توفر معلومات جديدة أثناء العلاج.

يمكن استخدام الفرضيات السريرية إما حصرياً من قبل مقدم الخدمة أو يمكن مشاركتها مع المرضى. بشكل عام، تعمل مشاركة هذه المعلومات على تحسين الثقة والتواصل بين المريض ومقدم العلاج.

قد تكون الفرضية السريرية المركزة للشخص المصاب بالاكتئاب كما يلي:

"منذ تقاعدك، مررت بالعديد من التحولات في حياتك وخسائر عديدة (على سبيل المثال، مالية واجتماعية ووظيفية). **أفكارك**، التي اعتادت أن تكون إيجابية وطموحة إلى حد كبير، أصبحت الآن سلبية ومتشائمة؛ ويبدو أنك تخشى مستقبل. كرد فعل على مزاجك وأفكارك السلبية، قمت بتقليل عدد أنشطتك؛ وقد بدأت بالانسحاب من عائلتك".

النتيجة النهائية عند تصور الحالة تقوم بتشكيل خطة العلاج، استراتيجية متفق عليها بين المريض والمعالج والتي تعطي التوجيه للعملية العلاجية. يجب أن تتضمن خطة العلاج عرضاً تقديمياً لأسباب الصعوبات الحالية للمريض (على سبيل المثال، العوامل المعرفية والسلوكية التي تخلق أعراضاً أو صعوبات) وخطة محددة. عند تقديم الخطة، قم بإشراك المريض بنشاط ودمج ملاحظاته.

مثال أثناء الجلسة 4.4

مثال: "في فترة وجيزة من الوقت الذي قضيناه معاً ، يبدو أننا حددنا بعض الأفكار والسلوكيات التي من المحتمل أن تساهم في الصعوبات الحالية. على وجه الخصوص، نظرتك إلى نفسك ومستقبلك سلبية تماماً ؛ وتوقفت عن فعل الكثير من الأشياء التي كانت تجلب لك المتعة. توصيتي هي مواصلة استكشاف أفكارك ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا إيجاد رؤية أكثر توازناً لصعوباتك الحالية. أود أيضاً أن أتحدث معك أكثر عن إعادة الانخراط في الأنشطة التي اعتدت أن تجدها ممتعة. ما رأيك في أهداف العلاج هذه؟ "

3. تصور الحالة الخطوة 3: تحديد العوائق العلاجية المحتملة

ليس من غير المألوف أن يوافق المرضى ببساطة على توصيات مزودهم. ومع ذلك، من المهم تحديد العقبات المحتملة أمام العلاج في وقت مبكر لتجنب الانتكاسات أو فشل العلاج. يساعد طلب التعليقات المتكررة من المريض على تقليل الامتنال المفرط ويعمل على تضمين المريض في نهج علاجي تعاوني ونشط. كجزء من هذا المشروع التعاوني، من المهم أن تسأل المرضى عما إذا كانوا يرون أي عقبات محتملة أمام العلاج. قد تشمل العوائق الصعوبات اللوجستية (المالية، والسفر) ، والمعتقدات الشخصية (مخاوف بشأن وصمة العار ، وفعالية العلاج) أو القضايا الشخصية (الأسرة لا تدعم العلاج).

تسليط الضوء 4.1

نصائح لاستخدام تصور الحالة في العلاج المعرفي السلوكي الموجز

- تصور الحالة باختصار في العلاج المعرفي السلوكي هو نفسه إلى حد كبير مع أشكال العلاج الأطول ، مع الاستثناءات التالية:

«العلاج الموجز يترك مجالاً صغيراً للتأخير في صياغة الحالة.

«يجب مراعاة القيود الزمنية للعلاج الموجز في جميع جهود العلاج / تحديد الأهداف. يجب أن تكون أهداف العلاج

معقولة وقابلة للقياس وبسيطة قدر الإمكان.

« بسبب الوقت المحدود ، فإن تركيز العلاج باختصار العلاج المعرفي السلوكي يحد بشكل عام من عمق التدخلات

المعرفية. على سبيل المثال، من الشائع جداً معالجة الأفكار التلقائية والمعتقدات الوسيطة باعتبارها بؤرة للعلاج، بينما

غالباً ما تكون معالجة المعتقدات الأساسية صعبة. إذا تمت معالجة المعتقدات الأساسية، فعادة ما يحدث هذا بشكل غير

مباشر من خلال المزيد من تقنيات التدخل السطحي أو في وقت يكون فيه المريض مستعداً بشكل خاص لمثل هذا العمل.

أمثلة على الواجبات المنزلية

1. فكر في خطة العلاج المتفق عليها ، وفكر في أي تعديلات قد تحتاجها.

2. ضع قائمة بأي عقبات قد تظهر أمام العلاج.

SUPPLEMENTAL READINGS

Beck, J.S. (2011). *Cognitive therapy: Basics and beyond* (2nd ed.). New York: Guilford Press; Chapter 3, 4, 5

Cormier, L. S., Nurius, P., & Osborn, C. J. (2017). *Interviewing and change strategies for helpers*. Boston, MA: Cengage Learning; Chapter 6.

Persons, J.B. & Tompkins, M.A. Cognitive-behavioral case formulation. In Ellis T. (Ed.). *Handbook of psychotherapy and case formulation*. New York: Guilford Press, pp. 314-339.